

DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général
Téléphone : 05 61 77 82 03

Directrice Générale Adjointe
Téléphone : 05 67 77 81 58

Secrétaire Générale
Téléphone : 05 67 77 83 81

Télécopie : 05 61 77 83 61

Toulouse, le 25 juin 2026

Mme Zaynab RIET
Déléguee Générale
Fédération Hospitalière de France
1bis rue Cabanis
75014 Paris

N/Réf. JFL/MR/ED 2026-089

Objet : Évolution des rémunérations et reconnaissance de l'expérience professionnelle dans la fonction publique hospitalière – situation particulière des ambulanciers

Madame la Déléguee Générale, *Chère Zaynab,*

Je souhaite partager avec vous une préoccupation que nous rencontrons aujourd'hui au sein de notre établissement concernant les perspectives de carrière et de rémunération des agents de la fonction publique hospitalière.

Les revalorisations successives du SMIC intervenues depuis le début de l'année 2026 – une première augmentation au 1er janvier 2026 (+1,18 %) puis une revalorisation complémentaire au 1er juin 2026 (+2,41 %) – ont eu pour conséquence de rapprocher significativement les premiers niveaux de rémunération de la fonction publique hospitalière du salaire minimum légal.

Dans ce contexte, l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique se situe désormais autour de l'indice majoré 380. Or, cet indice correspond, dans plusieurs grilles de catégorie C de la fonction publique hospitalière, à un niveau de rémunération atteint après environ huit années d'ancienneté. Il rejoint également les premiers niveaux de progression de certains corps de catégorie B. À titre d'exemple, un adjoint des cadres hospitaliers doit aujourd'hui atteindre le sixième échelon de sa grille, soit environ sept années d'ancienneté, pour accéder à un niveau de rémunération au moins équivalent à l'indice 380.

Cette évolution marque un point de bascule dans la gestion des carrières des professionnels. Au sein de notre établissement, près de 3 000 professionnels sur un effectif total d'environ 12 000 agents sont aujourd'hui payés à l'indice majoré 380, soit près de 25 % des effectifs.

Au-delà de la situation locale, cette évolution soulève un enjeu national qui concerne l'ensemble des établissements publics de santé. Les grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière, particulièrement celles des catégories C, ne permettent plus aujourd'hui de garantir une progression salariale suffisamment lisible et différenciée au regard de l'expérience acquise. Le rattrapage progressif des rémunérations par le SMIC conduit à un effacement des écarts entre les premiers échelons et ceux atteints après plusieurs années d'exercice.

À titre d'exemple, un agent recruté aujourd'hui au premier échelon du grade d'ouvrier principal peut percevoir une rémunération équivalente à celle d'un professionnel ayant atteint un indice majoré de 377, correspondant à huit années d'ancienneté dans la fonction publique hospitalière. Une telle situation remet en question la reconnaissance de l'expérience professionnelle et contribue à estomper la lisibilité des perspectives d'évolution offertes aux agents.

Le recours à l'indemnité différentielle permet de garantir à chaque agent le respect du niveau minimum de rémunération fixé par le SMIC. Ce dispositif est indispensable pour préserver le pouvoir d'achat des professionnels dans un contexte économique marqué par l'inflation et l'augmentation du coût de la vie.

Toutefois, cette indemnité n'est pas intégrée dans l'assiette de calcul des droits à pension. Cette situation est parfois difficilement comprise par les agents qui peuvent avoir le sentiment qu'une partie de leur rémunération, bien que perçue mensuellement, ne participe pas à la reconnaissance de leur carrière ni à la constitution de leurs droits futurs.

Les conséquences de cette situation dépassent désormais la seule question technique de la rémunération. Sur le terrain, nous constatons une incompréhension croissante des agents face à des mécanismes devenus difficilement lisibles. Cette évolution fragilise les politiques de gestion des ressources humaines que nous conduisons au sein des établissements et réduit la portée des dispositifs visant à reconnaître l'engagement, l'expérience et les compétences acquises tout au long du parcours professionnel.

Elle nourrit également un mécontentement de plus en plus perceptible parmi les personnels. Les sollicitations adressées à la direction pour obtenir des revalorisations salariales traduisent une attente légitime de reconnaissance de l'investissement professionnel consenti, de la technicité des missions exercées et des contraintes inhérentes aux métiers hospitaliers. Au-delà de la rémunération elle-même, c'est la valeur accordée au travail accompli qui est ici interrogée.

Les préoccupations exprimées dans le cadre du dialogue social et relayées par les organisations syndicales font écho à ce sentiment. Elles traduisent les inquiétudes d'un nombre croissant de professionnels qui constatent un effacement progressif des écarts de rémunération liés à l'ancienneté et à l'expérience, remettant en cause l'un des fondements de la progression de carrière dans la fonction publique hospitalière.

Les constats que nous dressons au sein de notre établissement ne nous paraissent pas isolés. Au fil des échanges que nous pouvons avoir avec nos collègues directeurs d'établissements publics de santé, ces interrogations sur l'évolution des rémunérations et la lisibilité des parcours et des carrières sont régulièrement évoquées. C'est dans ce contexte, et en ayant pleinement conscience de la mobilisation constante de la Fédération hospitalière de France sur les enjeux d'attractivité et de reconnaissance professionnelle, que je souhaitais partager avec vous ces éléments de réflexion et de retour d'expérience.

Face à cette situation, il apparaît indispensable qu'une réflexion nationale soit engagée sur l'évolution des grilles indiciaires afin de restaurer des parcours professionnels cohérents, attractifs et porteurs de perspectives d'évolution clairement identifiables.

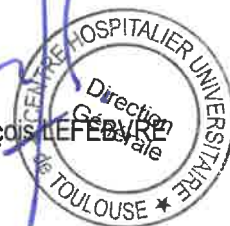
Une mobilisation de la Fédération hospitalière de France sur ce sujet constituerait un signal fort pour les professionnels hospitaliers et contribuerait utilement aux réflexions nationales à conduire en matière d'attractivité et de reconnaissance des métiers.

Je vous prie de croire, Madame la Déléguée Générale, à l'assurance de mes salutations distinguées et respectueuses.

Amélie

Le Directeur Général,

Jean-François LEFEBVRE



DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général

Téléphone : 05 61 77 82 03

Directrice Générale Adjointe

Téléphone : 05 67 77 81 58

Secrétaire Générale

Téléphone : 05 67 77 83 81

Télécopie : 05 61 77 83 61

Toulouse, le 15 juillet 2026

Madame Zaynab RIET
Délégue Générale
Fédération Hospitalière de France
1bis rue Cabanis
75014 Paris

N/Réf. JFL/MR/CR 2026-105

Objet : Situation des ambulanciers du CHU de Toulouse et demandes indemnitaires

Madame la Délégue Générale,

Je souhaitais partager avec vous la situation rencontrée au CHU de Toulouse concernant les ambulanciers hospitaliers, qui soulève des interrogations d'une manière plus générale sur l'application de plusieurs dispositifs indemnitaires.

Depuis le 11 mai 2026, ces professionnels sont engagés dans un mouvement social. Malgré plusieurs séquences de dialogue social et la recherche de solutions permettant de répondre à leurs attentes, certaines revendications n'ont pu trouver de réponse au regard du cadre réglementaire actuellement applicable.

Les demandes exprimées portent essentiellement sur des mesures de revalorisation indemnitaire qui traduisent, au-delà des dispositifs sollicités eux-mêmes, une volonté d'obtenir une meilleure reconnaissance de leur engagement et une revalorisation de leur rémunération, dans un contexte marqué par le tassement des grilles indiciaires consécutif aux deux revalorisations légitimes du SMIC intervenues en 2026.

Les revendications portent plus particulièrement sur :

- L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 20 points, actuellement réservée aux conducteurs de véhicules affectés aux structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR),
- À défaut, l'attribution de la NBI de 10 points prévus pour les professionnels exerçant leurs fonctions au sein des chambres mortuaires,
- Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de risque (IFR),
- L'application d'une indemnité de résidence au taux de 3 %.

Je suis sensible aux préoccupations exprimées par ces professionnels. Les ambulanciers hospitaliers constituent un maillon essentiel de la chaîne hospitalière et assurent quotidiennement des missions indispensables à la continuité des prises en charge. Les évolutions récentes de leur métier, notamment leur intégration au sein de la filière soignante, renforcent légitimement des attentes.

Les analyses juridiques conduites par mes services m'amènent toutefois à considérer que les dispositifs revendiqués ne peuvent, en l'état des textes, être étendus aux ambulanciers du CHU de Toulouse.

S'agissant de la NBI de 20 points, celle-ci est expressément réservée aux conducteurs de véhicules affectés aux structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Au CHU de Toulouse, l'organisation retenue distingue clairement les équipes dédiées au SMUR des équipes d'ambulanciers hospitaliers polyvalents, ces dernières assurant les transports sanitaires de patients dans le cadre de l'activité hospitalière. Les ambulanciers à l'origine des revendications n'exercent donc pas les missions ouvrant droit, en l'état des textes, au bénéfice de cette NBI.

La NBI de 10 points est, quant à elle, attachée à l'exercice effectif de fonctions au sein des chambres mortuaires. Ce dispositif est directement lié à la nature des missions exercées dans ces structures et ne paraît pas pouvoir être étendu à d'autres fonctions, quelles que soient les contraintes qu'elles présentent.

L'indemnité forfaitaire de risque est réservée aux professionnels exerçant dans des structures autorisées au titre de la médecine d'urgence. Si les ambulanciers hospitaliers participent pleinement à la prise en charge des patients, ils n'exercent pas leurs missions dans le périmètre des structures visées par les textes.

Enfin, l'indemnité de résidence constitue un élément statutaire de rémunération dont le taux est fixé par les dispositions réglementaires en fonction du classement géographique de la commune d'affectation. Cette demande aussi légitime soit-elle, ne peut donc faire l'objet d'une modulation par décision locale.

Les services de la Fédération Hospitalière de France, avec qui la Direction des Ressources Humaines du CHU de Toulouse a pu échanger, semblent nous confirmer que cette lecture juridique est conforme aux textes en vigueur. Pour autant, les revendications exprimées témoignent d'une difficulté plus large de reconnaissance salariale d'une profession dont les missions ont évolué ces dernières années.

C'est pourquoi, je souhaitais avoir confirmation de votre analyse sur ces différents dispositifs, au regard de leur interprétation juridique et connaître les éventuelles perspectives d'évolution qui pourraient être identifiées par la Fédération hospitalière de France. Je serais également intéressé par tout retour d'expérience dont vous disposeriez sur des situations similaires rencontrées dans d'autres établissements.

Je vous prie de croire, Madame la Déléguée Générale, à l'assurance de mes salutations distinguées et respectueuses.

Auntis

Le Directeur Général

Jean-François LEFEBVRE


Jean-François Lefebvre
Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire de Toulouse
Hôtel-Dieu Saint-Jacques,
2, rue Viguerie - TSA 80035
31059 Toulouse Cedex 9
France

Objet : Grève des ambulanciers inter-hospitaliers du CHU de Toulouse

Monsieur le Directeur général,

Nous, députés de la Haute-Garonne, souhaitons appeler solennellement votre attention sur la situation des ambulanciers et ambulancières inter-hospitaliers du CHU de Toulouse, engagés dans un mouvement de grève illimitée depuis le 11 mai dernier.

Ce conflit, désormais installé dans la durée, ne peut être regardé comme un simple différend technique ou indemnitaire. Il révèle une difficulté plus profonde : celle de la reconnaissance de personnels essentiels au fonctionnement quotidien du service public hospitalier, mais encore trop souvent maintenus dans l'invisibilité administrative.

Les ambulanciers inter-hospitaliers du CHU assurent des missions indispensables à la continuité des soins. Ils prennent en charge des transports inter-hospitaliers, interviennent dans des situations d'urgence, accompagnent des patients vulnérables, assurent des transports de détenus ou de corps, et sont régulièrement confrontés à des situations sensibles, parfois physiquement, psychologiquement ou sécuritairement exposées. Ces missions ne relèvent pas d'un simple appui logistique périphérique. Elles participent pleinement à la chaîne du soin.

C'est précisément ce décalage qui nourrit aujourd'hui la colère des personnels. Les agents concernés indiquent être maintenus dans un rattachement administratif qui ne correspond plus à la réalité de leurs missions, alors même que l'évolution de leur métier, des responsabilités exercées et des risques encourus appelle une reconnaissance claire.

Leurs revendications sont connues. Elles portent sur l'examen effectif de leur situation au regard de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), de l'indemnité de fonctions et de résultats, ainsi que sur une révision complète de leur fiche de poste.

Elles portent également sur la question de leur rattachement à la Direction des soins, plutôt qu'à une organisation principalement logistique, afin que leur positionnement institutionnel corresponde enfin à la réalité du travail accompli.

Nous considérons que cette demande mérite une réponse de fond. À l'heure où l'hôpital public repose trop souvent sur l'engagement de personnels sous tension, il n'est pas acceptable que des agents exerçant des missions aussi sensibles aient le sentiment d'être renvoyés à une catégorie administrative qui invisibilise leur contribution réelle à la prise en charge des patients.

La situation est d'autant plus préoccupante que les représentants des personnels font état d'une absence d'avancée concrète à l'issue des échanges engagés avec la direction. Après plusieurs semaines de mobilisation, le maintien du blocage ne peut tenir lieu de réponse. Le dialogue social ne peut être réduit à une succession de réunions sans perspective tangible.

Nous ne méconnaissons ni les contraintes budgétaires qui pèsent sur les établissements publics de santé, ni la complexité des règles statutaires. Mais ces contraintes ne peuvent justifier une situation dans laquelle des personnels indispensables au fonctionnement du CHU ont le sentiment d'être durablement ignorés.

Au regard de la durée du mouvement, de son durcissement et du rôle essentiel de ces agents dans la continuité du service public hospitalier, il nous paraît indispensable qu'un signal clair soit donné rapidement.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les suites que vous entendez donner à cette situation et les conditions dans lesquelles un dialogue réel peut reprendre sans délai.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de notre haute considération.

Les députés Socialistes de la Haute-Garonne

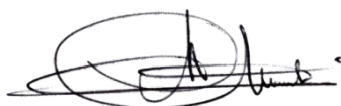
Joël Aviragnet

Député de la 8^e circonscription de la Haute-Garonne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Aviragnet', with a stylized flourish at the end.

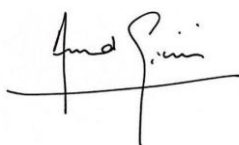
Jacques Oberti

Député de la 10^e circonscription de la Haute-Garonne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Oberti', with a large, circular flourish at the beginning.

Arnaud Simion

Député de la 6^e circonscription de la Haute-Garonne

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Simion', with a horizontal line at the bottom.

Corinne VIGNON
Députée de Haute-Garonne
*Commissaire à la défense nationale
et aux forces armées*
*Présidente du groupe d'études
condition et bien-être des animaux*

Madame Stéphanie RIST
Ministre de la Santé, des Familles,
de l'Autonomie et des Personnes
handicapées
14, avenue Duquesne
75007 PARIS

Dossier suivi par :
Arsène GORNIK
Tél. : 06.43.41.86.13
Réf : CV/AG-2026-06-68

À Toulouse,
le 12 juin 2026

Madame la Ministre, *Chère Stéphanie*

Je souhaite attirer votre attention sur la situation des ambulanciers et ambulancières inter-hospitaliers du CHU de Toulouse, actuellement en grève illimitée depuis le 11 mai 2026, qui m'ont saisie d'un courrier exposant en détail leurs difficultés et leurs demandes.

Ces personnels assurent des missions indispensables à la continuité des soins (transports inter-hospitaliers, interventions en urgence, accompagnement de patients vulnérables, transports de détenus ou de corps), pleinement intégrées à la chaîne du soin. Leur reconnaissance en tant que soignants est inscrite dans le Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière, qui les intègre à la filière soignante, et confirmée par le Conseil d'État quant à l'ouverture de droits à la NBI et à l'IFR. Ils indiquent toutefois que, contrairement à d'autres CHU, cette reconnaissance n'est pas mise en œuvre à Toulouse, où ils restent rattachés à la filière logistique, avec les conséquences statutaires et indemnitaires que cela entraîne.

Alertée par la durée de ce conflit, l'absence d'avancées concrètes dans le dialogue social local et le rôle essentiel de ces agents dans le service public hospitalier, je souhaite relayer leur demande d'ouverture d'un dialogue avec la direction du CHU et vos services, afin d'examiner les conditions de mise en œuvre effective du décret précité et d'une meilleure prise en compte de leurs missions soignantes.

Vous trouverez en pièce jointe le courrier détaillé du collectif des ambulanciers inter-hospitaliers du CHU de Toulouse, qui explicite précisément le cadre juridique invoqué. Je serais reconnaissante de bien vouloir m'indiquer quelles suites vous entendez donner à cette alerte et dans quel cadre un échange constructif pourrait être engagé avec ces professionnels.

Je reste à votre entière disposition, ainsi que mon équipe, pour tout complément d'information.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération.

Bien Amicalement

Corinne VIGNON
Députée de Haute-Garonne

Toulouse, le 19 JUIN 2026

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Monsieur Jean-François LEFEBVRE
Directeur Général
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

dg.sec@chu-toulouse.fr

Références à rappeler : JLM/LMS/26 017 098-r

Monsieur le Directeur Général,

J'ai été saisi par les représentants des ambulanciers inter-hospitaliers du CHU de Toulouse, actuellement mobilisés depuis le 11 mai, souhaitant attirer mon attention sur leur situation.

Comme vous le savez, ces professionnels exercent des missions essentielles à la continuité et à la qualité de la prise en charge des patients au sein du principal Centre hospitalier de notre métropole.

À ce titre, ils expriment des attentes portant notamment sur la reconnaissance de leur rôle et de leur statut, en lien avec les dispositions d'un décret du 26 décembre 2022.

Sans préjuger des échanges en cours ni des responsabilités respectives de chaque partie dans la situation existante, il me paraît important que les conditions d'un dialogue social constructif puissent être réunies afin d'examiner ces revendications de manière sereine et approfondie.

Ce sont les raisons pour lesquelles je prends la liberté de vous saisir sur ce dossier et afin que les voies d'une issue rapide et équilibrée à cette situation puissent être trouvées.

La présente démarche s'inscrit dans une volonté d'écoute et d'attention portée à l'ensemble des acteurs concernés. Elle se veut respectueuse du cadre de gouvernance de votre établissement et attentive au maintien d'un dialogue apaisé.

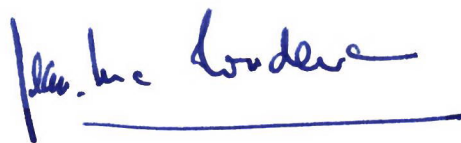
.../...



Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me tenir informé des suites qui pourraient être données à cette situation.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

et cordialement.

A handwritten signature in blue ink, reading "Jean-Luc Moudenc", written over a horizontal line.

Jean-Luc MOUDENC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

Madame **Anne Stambach-Terreñoir**
Monsieur **Hadrien Clouet**
Monsieur **François Piquemal**
Monsieur **Christophe Bex**

Député.es de la Haute-Garonne.

Monsieur **Jean-François Lefebvre**
Directeur général du CHU de Toulouse

Toulouse, le 18 mai 2026

Objet : Grève des ambulanciers du CHU de Toulouse et revalorisation de la profession

Monsieur le Directeur général,

Nous avons été interpellés par les ambulanciers internes du CHU de Toulouse qui ont lancé un mouvement de grève illimitée le lundi 11 mai dernier. En cause, le manque criant de reconnaissance des agents assurant les missions de transports. Ce mouvement de grève est suivi à près de 80% des agents relevant du service, ce qui démontre la présence généralisée d'un réel mal-être.

A la source du mécontentement, le nombre important de nouvelles missions lourdes de responsabilités et de dangers encourus qui ont été ajoutées ces dernières années, notamment :

- des interventions du SAMU et des missions d'urgence ;
- des transports de corps ;
- des transports de détenus (parfois sans équipement de protection).

Tout cela sans reconnaissance ou revalorisation supplémentaire, alors même que le point d'indice a été gelé pendant 15 ans et que l'inflation cumulée sur la même période est de plus de 28%.

D'autres CHU ont pourtant pris la décision d'attribuer des revalorisations, tel est le cas par exemple à Tours et à Angers où les ambulanciers perçoivent la NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire) et l'IFR (Indemnité Forfaitaire de Risque), conformément à la décision n°467063 du 19 juillet 2023 du Conseil d'État. À notre sens, aucun facteur ne pourrait justifier une telle

différence de traitement à Toulouse alors que les ambulanciers assurent des missions similaires à leurs collègues d'autres villes.

Nous tenons donc à leur assurer notre soutien inconditionnel et sommes à votre disposition pour engager un dialogue.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre considération distinguée.

Anne Stambach-Terrenoir

Hadrien Clouet

François Piquemal

Christophe Bex

Député.es de la Haute-Garonne.

La Déléguée Générale

Monsieur Jean-François LEFEBVRE
Directeur général
CHU de Toulouse
25 rue Jean-Baptiste DUMAS
31200 TOULOUSE

Paris, le 20 juillet 2026

N/Réf. : 26-075

Objet : Evolution des rémunérations et reconnaissance de l'expérience professionnelle dans la Fonction publique hospitalière – Situation particulière des ambulanciers

Monsieur le Directeur Général,

C'est avec une attention particulière que j'ai pris connaissance de vos courriers datés respectivement des 1^{er} et 15 juillet derniers.

Je vous confirme, en première intention, que l'analyse juridique réalisée par vos services au sujet des différents dispositifs indemnitaires faisant l'objet des échanges en cours avec les ambulanciers du CHU de Toulouse rejoint la lecture que nous pouvons faire, à ce jour, des textes en vigueur dans leur diversité. Elle reflète parfaitement la complexité inhérente à la gestion du régime indemnitaire applicable aux métiers de la Fonction publique hospitalière, composé d'une centaine de primes et indemnités de nature, de fonctionnement et de contrevalet très diversifiés.

Cet état de fait est un réel facteur de déficit de lisibilité des rémunérations pour nos professionnels. Il génère par ailleurs un poids de gestion tout à fait excessif pour un résultat peu satisfaisant en termes de valorisation des équipes, voire contreproductif en raison de la compréhension difficile qui en découle et du risque d'erreur majoré.

La FHF porte en conséquence auprès des pouvoirs publics comme chantier prioritaire l'enjeu d'une réforme en profondeur de ce régime indemnitaire, de manière à le faire évoluer vers un système non seulement plus lisible, mais également plus adaptable aux réalités organisationnelles, à la technicité des fonctions occupées, à la mise en œuvre d'expertises et à l'exercice de responsabilités particulières – y compris managériales – et à l'investissement rendu nécessaire par les contraintes de fonctionnement.

Les versants étatique et territorial de la Fonction publique bénéficient de cette évolution depuis plusieurs années, à travers le modèle du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). Pour la Fonction publique hospitalière, les perspectives de travail sont à ce stade fixées par les pouvoirs publics à l'horizon 2027.

La FHF partage également les éléments d'analyse relatifs aux revalorisations successives du SMIC et à l'écrasement des grilles de rémunération qui en résulte pour plusieurs métiers de la Fonction publique hospitalière.

A ce titre, dès janvier 2026 et la mise en œuvre de l'indemnité différentielle, les alertes subséquentes ont été adressées à la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) et à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFFP).

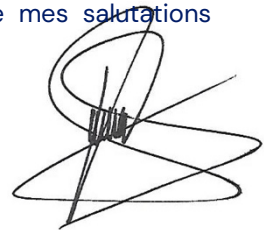
Ce 8 juillet, le Ministre de l'action et des comptes publics a réuni en un rendez-vous salarial de la Fonction publique les représentants des employeurs publics et les organisations syndicales représentatives. Il en résulte que, si une revalorisation uniforme du point d'indice est exclue, l'engagement d'une démarche structurante visant à traiter progressivement le tassement des grilles et à réduire le nombre d'agents dépendant de l'indemnité différentielle a été annoncé. Une concertation technique devrait être engagée à la sortie de l'été 2026 sur les options envisageables en la matière.

Deux autres pistes de travail ont été annoncées pour les mois à venir :

- Une réforme structurelle des règles de prise en compte de l'expérience professionnelle ;
- Une facilitation de l'accès à la promotion, via l'amélioration des taux de promotion pour les catégories B et C, ainsi que pour certains métiers de catégorie A, et un travail sur les quotas de promotion interne.

Ces différentes perspectives rejoignent des propositions portées de manière continue par la FHF depuis le début des années 2020. Dans l'attente de leur concrétisation, il nous apparaît qu'elles devraient être de nature à renforcer les capacités d'action de nos établissements en termes d'attractivité et de dynamisme des parcours professionnels.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l'assurance de mes salutations distinguées.



Zaynab RIET

Toulouse, le 19 JUIN 2026

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Monsieur Victor ALAVA
Syndicat SUD Solidaires Toulouse
Monsieur Sébastien BOUSSY
CGT CHU Toulouse
Monsieur Jérôme JEAN CHARLES
Délégué du personnel ambulancier
Monsieur Laurent BEZIA
Délégué du personnel ambulancier

bezialaurent@gmail.com

Références à rappeler : JLM/LMS/26 017 098-r

Messieurs,

Vous avez souhaité attirer mon attention sur la situation des ambulanciers inter-hospitaliers du CHU de Toulouse et sur le mouvement de grève engagé depuis le 11 mai dernier.

Sensible à votre mobilisation et aux préoccupations que vous exprimez, j'ai souhaité relayer ces éléments auprès de Monsieur Jean-François LEFEBVRE, Directeur Général du CHU, afin d'appeler son attention sur les attentes formulées et sur la nécessité de favoriser l'instauration d'un dialogue social constructif.

Dans ce cadre, je lui ai adressé un courrier visant à encourager toute initiative susceptible de permettre une issue rapide, équitable et équilibrée à la situation actuelle, dans le respect des responsabilités de chacun.

A cet égard, je tiens également à souligner toute l'importance que je porte à l'engagement des ambulanciers hospitaliers, dont l'action quotidienne contribue pleinement au bon fonctionnement du service public de santé sur notre territoire.

Vous trouverez ci-joint copie de cette correspondance, que j'ai souhaité porter à votre connaissance. J'espère que cette démarche pourra vous être utile et contribuer, autant que possible, à favoriser une évolution positive de la situation.

.../...



Je vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bien à vous
Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc MOUDENC

PJ : 1